



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA BULAN MARET
INSTALASI GIZI
TAHUN 2026**

I. SDM

I.1. Ketenagaan

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	Maret 2026	Kebutuhan	
Ka. Penunjang Medik	1	1	0	Lampiran
Ka. Unit	1	1	0	Lampiran
Pelaksana Gizi	5	5	0	Lampiran
Pelaksana Dapur	10	10	0	Lampiran

I.2. Pemenuhan Kualifikasi SDM

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi				Keterangan
	Standar	Kondisi saat ini	PPI dasar	Komunikasi Efektif	Penanggulangan Bencana	BHD	
Ka. Unit	D3/S1	D3	+	+	+	+	Internal
Pelaksana	D3 D4 S1	D3 D4 S1	+	+	+	+	Internal
Penyaji	SMA/K	SMA/K	+	-	+	+	Internal
Pengolahan	D1, SMA/K	SMP/S MA/K	+	-	+	+	Internal
Pemorsian	D1, SMA/K	SMA/K	+	-	+	+	Internal

I.3. Orientasi

Tidak ada orientasi karyawan baru pada Bulan Maret 2026

I.4. Pendidikan dan Pelatihan

Tidak terdapat diklat pada Bulan Maret 2026

I.5. Evaluasi kinerja Staf

Dilakukan evaluasi kinerja baik SDM maupun pelayanan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara OPPE oleh bagian SDM setiap 1 semester.

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

No.	Kegiatan Pengembangan Pelayanan	Rincian Kegiatan
1.	QC sesuai sistem HACCP	a. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. b. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. c. Memastikan 7 prinsip HACCP. d. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.
2.	Pemesanan diet melalui Whatsapp dan spreadsheet	a. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet.

No.	Kegiatan Pengembangan Pelayanan	Rincian Kegiatan
		b. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di grup whatsapp jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. c. Proses cetak label langsung efisien sesuai dengan diet ter update

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

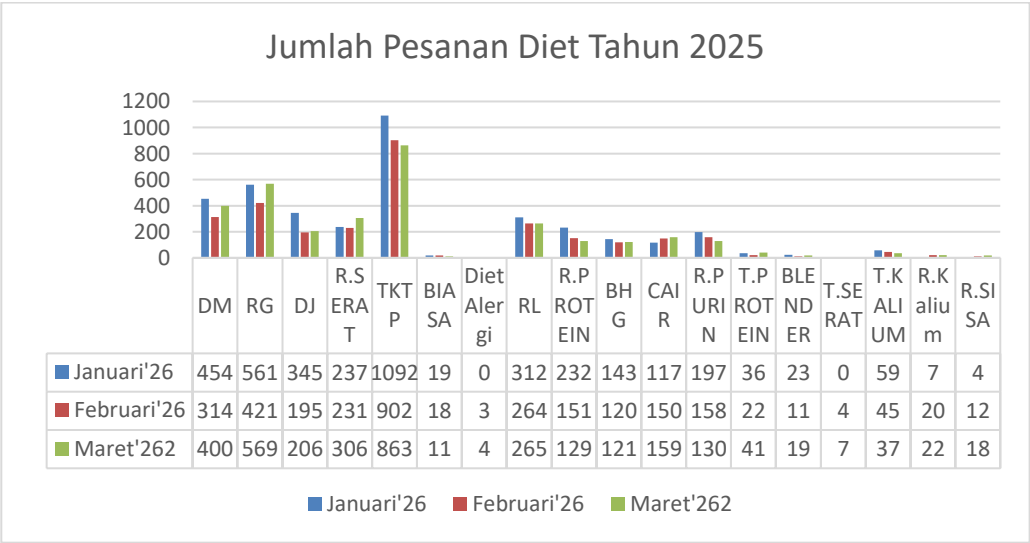
III.1. Pemberian Diet Pasien

(Perhitungan berdasarkan data pemberian diet pasien di rawat inap)

Tabel 3.1. Jumlah Pesanan Diet pada Bulan Maret Tahun 2026

No .	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Januari 2026	Bulan Februari 2026	Bulan Maret 2026	
1.	Diabetes Mellitus	454	314	400	27,3
2.	Rendah Garam	561	421	569	35
3.	Jantung	345	195	206	5,6
4.	Rendah Serat	237	231	306	32,4
5.	TKTP	1092	902	863	-4,3
6.	Makanan Biasa	19	18	11	-38,8
7.	Diet Alergi	0	3	4	33,3
8.	Rendah Lemak	312	264	265	0,37
9.	Rendah Protein	232	151	129	-14,5
10.	Bubur Halus	143	120	121	0,83
11.	Cair	117	150	159	6
12.	Rendah Purin	197	158	130	-17,7
13.	Tinggi Protein	36	22	41	86,3
14.	Blender	23	11	19	72,7
15.	Tinggi Serat	0	4	7	75
16.	Tinggi Kalium	59	45	37	-17,7
17.	Rendah Kalium	7	20	22	10
18.	Rendah Sisa	4	12	18	50
Jumlah		4208	3041	3307	8,7

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Pesanan Diet di Unit Gizi Pada Bulan Maret 2026



Analisis : Jumlah pesanan diet pasien rawat inap meningkat seiring dengan

meningkatnya jumlah pasien di rawat inap. Pemberian diet DM meningkat karena banyaknya pasien rawat inap dengan diagnosa diabetes militus. Diet pasie rendah garam juga meningkat seiring dengan diagnosa hipertensi. Pasien dengan diagnosa rendah sarat meningkat dengan pasien keluhan diare. Bentuk makanan cair mengalami kenaikan, dikarenakan permintaan pasien rawat inap terhadap makanan cair juga meningkat, biasanya makanan cair diminta karena dipengaruhi oleh faktor kesadaran pasien. Diet yang mengalami penurunan adalah diet rendah protein, rendah purin, TKTP, dan tinggi kalium.

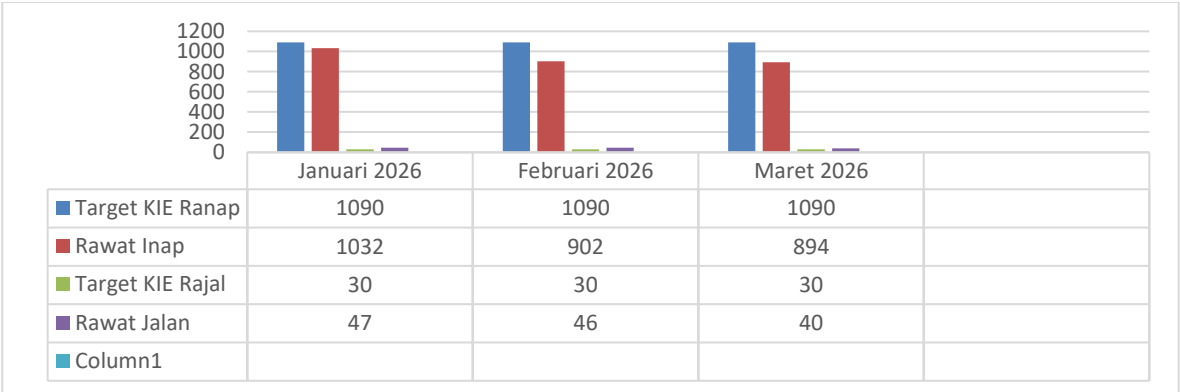
RTL : Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu dan mutu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

III.2. Jumlah Konsultasi Gizi

Tabel 3.2 Jumlah Konsultasi Gizi

No.	Indikasi	Jumlah Pasien Januari 2026	Jumlah Pasien Februari 2026	Jumlah Pasien Maret 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	1032	902	894
2.	Konsultasi Rawat Jalan	47	46	40

Gambar 3.2 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis : Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada bulan Maret menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan bulan Maret mengalami penurunan namun tidak signifikan dikarenakan DPJP sudah mulai aktif melakukan rujukan konseling gizi rawat jalan. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ardhany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

RTL : Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

III.3. Pencapaian Kinerja Gizi

Tabel 3.3. Pencapaian kinerja gizi dari Bulan Januari – Maret 2026

Kegiatan	JAN 26	FEB 26	MAR 26	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)	MAR 25	% Capaian Bulan Jan 2026 : 2025
Pemberian Diet pasien Rawat Inap	3838	3041	3307	8,74 (↑)	3194	103 (↑)
Konsultasi Gizi Rawat Inap	1032	902	894	0,88 (↓)	1038	86,12 (↑)
Konsultasi Gizi Rawat Jalan	47	46	40	13.04 (↓)	14	285 (↑)

Gambar 3.3 Grafik Pencapaian Kinerja Gizi



Analisis : Konsultasi gizi rawat inap bulan Maret 2026 meningkat dibandingkan bulan Februari. Konsultasi gizi rawat jalan bulan Maret 2026 menurun karena DPJP memberikan rujukan ke poli gizi (tidak semua poli, hanya beberapa poli seperti poli jantung dan IPD) diberikan rujukan saat pasien bertanya terkait pantangan makan yang dijalankan oleh pasien saat control ke polinya.

RTL : Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan. Mengajukan revisi siklus makan pasien untuk meningkatkan variasi menu.

Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi. Memberikan contoh resep masakan dalam leaflet edukasi diet pasien.

III.4. Diet IRNA

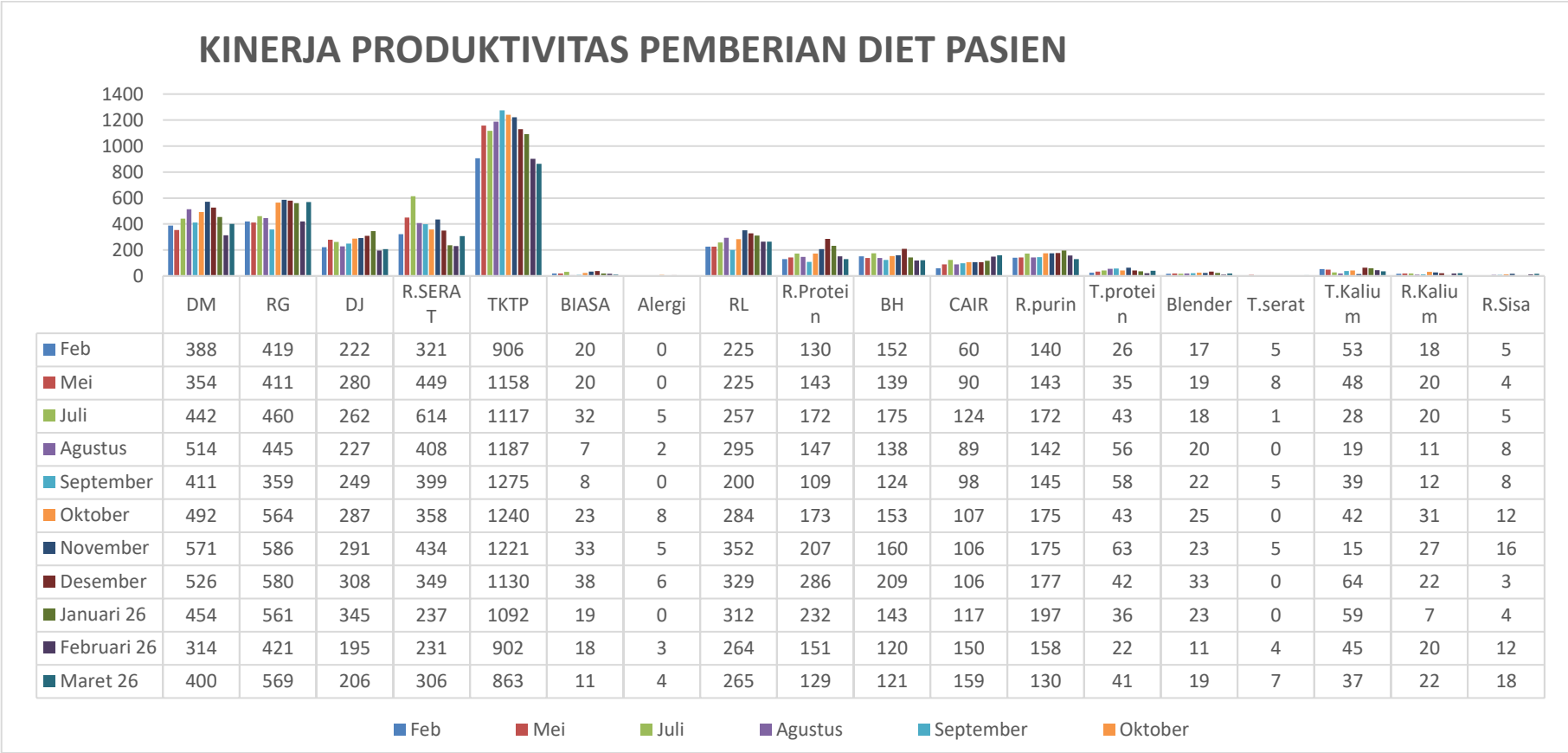
Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Produktivitas Pemberian Diet Rawat Inap RSPHM Bulan Januari s/d Maret 2026

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PRo	B.H	CAIR	R.PRN	T.PRo	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
1.	Des'25	526	580	308	349	1130	38	6	329	286	209	106	177	42	33	0	64	22	3
	Jan'26	454	561	345	237	1092	19	0	312	232	143	117	197	36	23	0	59	7	4
	Analisis	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah px yang rawat inap dengan diet tersebut meningkat	Pemberian diet rendah serat menurun karena diagnosa TF dan GEA sedikit .	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosa dengan diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Tidak terdapat pasien alergi	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mampu menyang	Pasien yang membutuhkan diet rendah purin meningkat seiring dengan hasil penunjang (UA) dan RPD Asam urat	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak banyak. Karena albuminnya normal .	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut tidak ada	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium menurun karena sedikit pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa karena post hemoroid agar tidak BAB dulu.

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PRo	B.H	CAIR	R.PRN	T.PRo	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
2.	Jan'26	454	561	345	237	1092	19	0	312	232	143	117	197	36	23	0	59	7	4
	Feb'26	314	421	195	231	902	18	3	264	151	120	150	158	22	11	4	45	20	12
	Analisis	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pemberian diet rendah serat menurun karena diagnosa TF dan GEA sedikit.	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mapuh mengunyah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak banyak. Karena albuminnya normal.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Terdapat pasien konstipasi sehingga diet T. Serat meningkat	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium meningkat karena banyak pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa meningkat karena post hemoroid atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PRo	B.H	CAIR	R.PRN	T.PRo	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
3.	Feb'26	314	421	195	231	902	18	3	264	151	120	150	158	22	11	4	45	20	12
	Mar'26	400	569	206	306	863	11	4	265	129	121	159	130	41	19	7	37	22	18
	Analisis	Diet DM meningkat seiring diagnosa diabetes mellitus	Diet rendah garam meningkat seiring diagnosa hipertensi	Diet jantung meningkat seiring diagnosa tersebut	Pemberian diet rendah serat meningkat karena diagnosa GEA meningkat.	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosa dengan diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mapuh mengunyah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang butuh diet tinggi protein meningkat, Diet tersebut seiring pasien pasca bedah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Terdapat pasien konstipasi sehingga diet T. Serat meningkat	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium meningkat karena banyak pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa meningkat karena post hemoroid atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

Gambar 3.4. Grafik Pencapaian Kinerja Produktivitas Pemberian Diet Rawat Inap RSPHM Bulan Januari s/d Maret 2026



Analisis : Pada bulan Maret pemberian diet pasien sebagian besar mengalami penurunan dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan rawat inap. Pemberian diet yang mengalami peningkatan adalah pemberian diet DM,rendah garam, jantung karena banyaknya pasien dengan keluhan terkait diagnosa tersebut. Diet rendah sisa juga mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya pasien dengan kondisi setelah operasi saluran cerna. Dan peningkatan bentuk makanan cair juga terjadi, karena banyak pasien dengan penurunan kesadaran. Akan tetapi ada beberapa diet yang mengalami penurunan yaitu diet TKTP, rendah protein, rendah purin dikarenakan menurunnya pasien dengan diagnosa yang membutuhkan diet tersebut.

RTL : Koordinasi dengan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien, dan meningkatkan kualitas pemberian diet pasien sesuai dengan kebutuhannya.

III.5 Permasalahan Unit

Tabel 3.5 Permasalahan Unit

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Tikus di dapur sudah berkurang, akan tetapi masih ada tikus yang berkeliaran dan hanya melewati jebakan yang sudah dipasang oleh vendor	P	Memperbaiki struktur gedung dapur agar tidak ada celah tempat tikus masuk ke dapur
		D	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan tukang RSPHM
		S	Kontaminasi makanan akibat adanya vector yang ada di lingkungan dapur
		A	Kolaborasi dengan tim IPSRS dan vendor untuk memperbarui jebakan tikus yang diletakkan di dapur, dan menutup akses keluar masuk tikus.
2	Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian	P	Alur penyerahan alat makanan harus bebas dari kontaminasi untuk menjamin higiene sanitasi alat makanan
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan IPSRS dalam pembuatan alur yang sesuai
		S	Risiko alat makan terkontaminasi makanan mentah sehingga tidak terjaga kebersihannya
3	E-RM poli rawat jalan gizi masih belum terlaksana	A	Tim gizi dan IPSRS berkolaborasi dalam pembuatan alur yang sesuai untuk penyerahan alat makan bersih ke tempat pemorsian
		P	Pemberian asuhan gizi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penulisan CPPT
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, programmer, dan pihak management RS dalam realisasi penulisan E-RM Poli gizi
		S	Risiko pemberian asuhan gizi tidak terintegrasi dan tidak adanya bukti ahli gizi telah melakukan edukasi kepada pasien rujukan poli dokter spesialis
4	Tingginya kasus kehilangan uang di unit gizi	A	Tim gizi , programmer, dan pihak managemen RS dalam realisasi penulisan ERM Gizi
		P	Meningkatkan keamanan dalam unit, dan peningkatan tindakan berhati-hati setiap orang
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, tim keamanan rumah sakit, dan pihak management RS dalam pemasangan CCTV
		S	Risiko kehilangan uang semakin sering
		A	Tim gizi dan tim keamanan rumah sakit berkolaborasi dalam mencari pelaku dan peningkatan keaamanan

IV. FASILITAS KESEHATAN DAN K3

IV.1. Fasilitas Kesehatan

4.1.1 Inventaris alat Unit Gizi

Tabel 4.1.1.a Inventaris alat Unit Gizi (Kantor Gizi)

No .	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Monitor (Set Pc)	1	Baik	-	-
2.		Cpu (Set Pc)	1	Baik	-	-
3.		Keyboard (Set Pc)	1	Baik	-	-
4.		Printer	1	Baik	-	-
5.		Smoke Detector	1	Baik	-	-
6.		AC (1 PK)	1	Baik	-	-
7.		Mouse	1	Rusak	-	Membeli yang baru memakai uang kas pribadi
8.		Kursi Kantor Roda	1	Baik	-	-
9.		Kursi Plastik Coklat	3	Baik	-	-
10.		Kursi Plastik Hijau	2	Baik	-	-
11.		Meja Kerja	1	Baik	-	-
12.		Lemari Rak File	2	Baik	-	-
13.		Lemari Kayu	1	Baik	-	-
14.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
15.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
16.		Papan IPD	1	Baik	-	-
17.		Box File	4	Baik	-	-
18.	Non medis – Non Listrik	Laci Plastik Atk Mini	1	Baik	-	-
19.		Cutter	1	Baik	-	-
20.		Double Tape	1	Baik	-	-
21.		Gunting	1	Baik	-	-
22.		Isolasi Bening	3	Baik	-	-
23.		Kalkulator	1	Baik	-	-
24.		Odner Hitam	5	Baik	-	-
25.		Karada Scan Body Composition	1	Baik	-	-
26.		Rak Plastik Susun 4	1	Baik	-	-
27.		Plong-Plongan	1	Baik	-	-
28.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-

Ruang Poli Gizi						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	AC	1	Baik	-	-
2.		Monitor (Set Pc)	1	Tidak pakai		
3.		Meja Kerja	1	Baik	-	-
4.		Kursi Kerja	1	Baik	-	-
5.		Kursi Pasien	2	Baik	-	-
6.		Box Food Model	1	Baik	-	-
7.	Non medis –Non Listrik	Food Model	1 set	Baik	-	-
8.		Lemari Penyimpanan	1	Baik	-	-
9.		Tumpeng Gizi Seimbang	1	Baik	-	-
10.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
11.		Microtoa	1	Baik	-	-
12.		Wastafel	1	Baik	-	-

Tabel 4.1.1.b Inventaris Alat Unit Gizi (Dapur)

Ruang Pencucian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Dishwasher	1	Baik	-	-
2.		Kipas Angin	2	Baik	-	-
3.		Exhaust Fan 40x40	1	Baik	-	-
4.	Non medis – Non Listrik	Kitchen Sink Greasetrap	1	Baik	-	-
5.		Rak Besi Susun 4	1	Baik	-	-
6.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
7.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
8.		Tray cuci	5	Baik	-	-
9.		Bak Peniris	3	Baik	-	-
10.		Gas Duck Roaster	1	Baik	-	-
11.		Heavy Duty Rice Cooker	1	Baik	-	-

Ruang Penerimaan Bahan Makanan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Showcase polytron	1	Baik	-	-
2.		Kipas Angin	1	Baik	-	-
3.		Insect Killer	1	Baik	-	-
4.	Non medis – Non Listrik	Kitchen Sink	2	Baik	-	-
5.		Rak Besi Susun 3	1	Baik	-	-
6.		Meja Penerimaan	1	Baik	-	-
7.		Loker Petugas Dapur	1	Baik	-	-
8.		Wastafel	1	Baik	-	-
9.		Timbangan Besi Duduk	1	Baik	-	-
10.		Timbangan Analog	1	Baik	-	-
11.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
12.		Rak Barang 5 Susun	1	Baik	-	-
13.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
14.		Box K3	1	Baik	-	-
15.		Tirai pvc	1	Baik	-	-

Ruang Pemorsian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Insect Killer	2	Baik	-	-
2.		AC	1	Baik	-	-
3.		Sealer	1	Baik	-	-
3.	Non medis – Non Listrik	Meja Pemorsian Besi	6	Baik	-	-
4.		Piring Makan Persegi Melamin Pasien Vip	40	Baik	-	-
5.		Mangkok Kecil Melamin	78	Baik	-	-
6.		Box Makan Pasien Dewasa	178	Baik	-	-
7.		Box Makan Pasien Anak	28	Baik	-	-
8.		Plato Makan Pasien Anak	10	Baik	-	-
9.		Tutup Box makan anak	16	Baik	-	-
10.		Gelas Pasien	86	Baik	-	-

Ruang Pemorsian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
11.		Sendok Pasien	138	Baik	-	-
12.		Mangkok Dokter	14	Baik	-	-
13.		Gelas melamin dokter	9	Baik	-	-
14.		Gelas keramik dokter	24	Baik	-	-
15.		Bel	1	Baik	-	-
16.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
17.		Wastafel	1	Baik	-	-
18.		Tempat Tisu	1	Baik	-	-
19.		Troli Makanan	9	Baik	-	-
20.		Piring Penunggu Pasien Vip Bulat	19	Baik	-	-
21.		Tutup Gelas Stainless	108	Baik	-	-
22.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-

Ruang Penyimpanan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Freezer Midea	1	Baik	-	-
2.		Freezer Modena	1	Baik	-	-
3.		Showcase Politron	1	Baik	-	-
4.		Kipas Angin Kdk	1	Baik	-	-
5.		Exhaust	3	Baik	-	-
6.		Kipas Angin Miyako	1	Baik	-	-
7.	Non medis –Non Listrik	Tray Pvc	1	Baik	-	-
8.		Thermohygrometer	4	Baik	-	-
9.		Lemari Rak Susun 4	4	Baik	-	-
10.		Ember Penyimpanan Beras	1	Baik	-	-
11.		Ember Penyimpanan Gula	1	Baik	-	-
12.		Box Kontainer Hitam	8	Baik	-	-
13.		Box Kontainer Transparan	8	Baik	-	-
14.		Toples Besar Transparan	2	Baik	-	-

Ruang Pengolahan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Magic Com	2	Baik	-	-
2.		Showcase Cooler merk GEA	1	Baik	-	-
3.		Blower	1 set	Baik	-	-
4.		Oven	1	Baik	-	-
5.		Blender	2	Baik	-	-
6.		Food Prosesor	1	Baik	-	-
7.		Insect Killer	1	Baik	-	-
8.	Non medis –Non Listrik	Rak Besi Susun 3	3	Baik	-	-
9.		Meja Besi Pengolahan	1	Baik	-	-
10.		Meja Kompor	1	Baik	-	-
11.		Kompor Rinai 2 Tungku	1	Baik	-	-

Ruang Pengolahan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
12.		Kompor Besar 1	1	Baik	-	-
13.		Kompor Stockpot	2	Baik	-	-
14.		Kitchen Sink	2	Baik	-	-
15.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
16.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
17.		Panci Besar	6	Baik	-	-
18.		Panci Kecil	4	Baik	-	-
19.		Apron	15	Baik	-	-
20.		Presto	3	Baik	-	-
21.		Peniris Minyak	5	Baik	-	-
22.		Termos Nasi Besar	4	Baik	-	-
23.		Pisau	16	Baik	-	-
24.		Talenan	3	Baik	-	-
25.		Spatula	9	Baik	-	-
26.		Cetakan Pukis	2	Baik	-	-
27.		Sendok Sayur	4	Baik	-	-
28.		Baskom Besar	2	Baik	-	-
29.		Baskom Kecil	2	Baik	-	-
30.		Wajan	10	Baik	-	-
31.		Baki Pasien	23	Baik	-	-
32.		Teflon	3	Baik	-	-
33.		Telepon Dapur	1	Baik	-	-
34.		Lemari Kayu	1	Baik	-	-
35.		Tirai Pvc	1	Baik	-	-
36.		Toples plastic 1500 ml	3	Baik	-	-

4.1.2 Kalibrasi

Tabel 4.1.2 Kalibrasi Alat

No .	Nama Alat	No. Seri	Frekuensi			Terakhir Kalibrasi	PJ
			Minggu	Bulan	Tahun		
1.	-						

4.1.3 Penambahan alat baru

Tabel 4.1.3 Penambahan Alat baru

No.	Nama Alat	Jumlah	No. Inventaris	No. Seri	Tanggal Pengajuan	Tanggal Barang Datang
1.	Heavy Duty Rice Cooker	1	-	-	-	23 Februari 2026
2.	Gas Duck Roaster	1	-	-	-	26 Februari 2026

4.1.4 Alat rusak

Tabel 4.1.4 Alat Dan Fasilitas Rusak

No.	Nama Alat	Jumlah	No. Inventaris	No. Seri	Penyebab Rusak	Tanggal Lapor	Tanggal Selesai
1.	Sealer	1	-	-	Skrup terlepas, sehingga tuas sealer tidak bisa ditarik	17 Februari 2026	17 Februari 2026

IV.2. GEDUNG DAN BANGUNAN

Tabel 4.2 Gedung dan Bangunan

No	Nama Unit	Luas Gedung (M ²)
1.	Instalasi Gizi	12,9 x 8,57
2.	Ruang Trolly Makanan	5,35 x 2,5

No.	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1.	Pemeliharaan alat & bangunan	a. Pada bulan ini dilakukan pembersihan rutin ruangan setiap hari. b. Dilakukan perbaikan sealer pemorsian karena sealer tidak bekerja sesuai fungsi. c. Ruang pemorsian yang ada saat ini tidak sesuai karena berada di lorong (akses jalan) hal tersebut sangat tidak disarankan karena akses jalan menjadi 1 arah, sementara standar bangunan di unit gizi harus 2 arah (pintu masuk dan keluar dibedakan). d. Ruang persiapan (untuk mempersiapkan bahan makanan dari pemotongan hingga siap diolah), selama ini petugas jika memotong sayuran dll dilakukan di ruang penerimaan bahan makanan dikarenakan belum tersedianya ruang persiapan. e. Belum tersedianya ruang perpustakaan mini di unit gizi guna menunjang ilmu terupdate terkait gizi. f. Alur penyerahan alat makan bersih ke ruang pemorsian masih belum standar karena melewati ruang pengolahan g. Gudang kering masih belum sesuai standart jarak rak dari dinding.
2.	Perbaikan sarana & prasarana	a. Ruang persiapan (untuk mempersiapkan bahan makanan dari pemotongan hingga siap diolah), selama ini petugas jika memotong sayuran dll dilakukan di ruang penerimaan bahan makanan dikarenakan belum tersedianya ruang persiapan. b. Belum tersedianya ruang perpusatakaan mini di unit gizi guna menunjang ilmu terupdate terkait gizi. c. Alur keluar masuk petugas gizi atau petugas lain yang akan ke unit gizi 1 arah yaitu melalui pintu pencucian peralatan makan pasien dan ruang pengolahan makanan. d. Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian

IV.3. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tabel 4.3. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

No.	Kegiatan Pokok	Jumlah	Keterangan
1.	Monitoring Kesehatan	-	a. Terdapat pemeriksaan kesehatan pada bulan Januari 2026 (rectal swab) b. Tidak dilakukan imunisasi pada bulan ini.
2.	PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	-	a. Pemberian makanan tambahan di berikan setiap hari Jum'at (Jum'at Berkah) b. Pemberian buka puasa dan takjil untuk seluruh karyawan shift MD dan sore selama bulan Januari - Februari c. Pemberian PMT kepada unit khusus seperti unit radiologi dan unit isolasi lantai 5
3.	Mangkir Kerja		
	a. Cuti	-	-
	b. Sakit	-	-
	c. Alpha	-	-
4.	Konseling	-	Konseling penyimpanan makanan setengah matangn dan matang Konseling penggunaan APD Konseling PPI
5.	Penyakit akibat kerja /kecelakaan kerja	-	-

Analisis :

1. Pemberian makanan tambahan bagi karyawan berupa jumat berkah diberikan secara rutin
2. Pemberian makanan tambahan bagi karyawan yang berbuka puasa diberikan dengan cara karyawan yang berpuasa melakukan pemesanan makanan buka 1 hari sebelum berbuka.
3. Pemberian makanan tambahan juga diberikan kepada unit berisiko seperti unit radiologi dan unit isolasi TBC lantai 5. Untuk lantai 5, pemberian makanan tambahan diberhentikan per tanggal 31 Januari 2026.
4. Konseling penyimpanan makanan setengah matang diberikan karena masih terdapat petugas yang tidak disiplin memberikan tanggal pembuatan makanan setengah matang, dan matang dan belum patuh pelabelan.
5. Konseling penggunaan APD dikarenakan masih ada petugas yang tidak disiplin dalam menggunakan APD masker bagi tim pengolahan dan penyaji serta seragam bagi tim pengolahan.
6. Konseling PPI, peningkatan kemampuan pegawai dan merefresh materi setiap minggunya.

RTL :

1. Sosialisasi kepada seluruh petugas instalasi gizi (Ahli gizi, pengolahan, dan penyaji) untuk menjaga kesehatan dengan cara istirahat cukup dan memperbaiki pola makan agar tidak gampang terkena penyakit.
2. Sosialisasi pemberian label pada makanan setengah matang sebagai pengaktifan sistem FIFO agar makanan yang dibuat lebih dulu dapat digunakan lebih dulu untuk mencegah makanan setengah matang rusak dan dapat berdampak pada mutu makanan secara rasa dan tampilan
3. Sosialisasi penggunaan APD untuk melindungi diri dan melindungi makanan agar terjaga kebersihannya

V. MUTU

Tabel 5.1. Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi

No.	Pengukuran	Standar	Hasil
1.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	87,8%
2.	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%
3.	Angka kelengkapan asuhan gizi	100%	100%
4.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	1
5.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0
6.	Kejadian makanan basi	0	0

Analisis :

1. Pasien B8A-12 Nurul Hidayati seharusnya diet DJ2 R.PROTEIN R.PURIN sejak makan siang-sore, namun tetap diberi diet DJ2 R.PROTEIN. Ahli gizi yang bertugas ahli gizi Alfira.

RTL :

1. Mempertahankan kinerja yang baik agar Indeks mutu prioritas unit tetap terjaga.
2. Melakukan edukasi dan pengkajian lebih dalam sebelum menyarankan.
3. Melakukan sosialisasi kepada tim penyaji untuk melakukan identifikasi pasien dengan baik agar kejadian kesalahan pemberian diet kepada pasien tidak terulang.

VI. Manajemen Risiko

No	Jenis Risiko	Grading Risiko	Pengendalian Risiko
Keselamatan			
1	Stress Kerja	Tinggi	Sosialisasi beban kerja
2	Terjatuh	Tinggi	Lantai tidak licin dan penandaan risiko
3	Terkena minyak panas	Tinggi	Penggunaan APD
4	Tersengat listrik	Tinggi	Penandaan risiko dan kabel rapih
5	Tersayat ATK	Moderate	Kewaspadaan petugas
Keamanan			
6	Terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR
7	Kehilangan	Moderate	Adanya lemari terkunci
B3			
8	Tumpahan B3 ATK	Ringan	Penyediaan spilkit B3
9	Tumpahan cairan B3	Tinggi	Pengamanan ruang yang aman
10	Kebocoran Gas	Tinggi	Pengamanan ruang yang aman
Kebakaran			
11	Konsleting listrik	Tinggi	Pemeriksaan listrik berkala
12	Komporebakar	Tinggi	Penyediaan APAR
13	Bahan kimia mudah terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR yang aman
Kedaruratan Bencana			
14	Kebakaran	Tinggi	Penyediaan fire protektive
15	Gempa Bumi	Tinggi	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah

16	Keracunan Makanan	Tinggi	Pemilahan bahan makanan yang bersih dan sesuai
Sistem Utilitas			
17	Kegagalan Listrik	Tinggi	Penggunaan genset
18	Kegagalan air bersih	Tinggi	Back up air bersih
19	Kegagalan jaringan internet	Ringan	Back up jaringan internet
20	Kegagalan SIMRS	Ringan	Back up data manual
Penanganan Darurat Bencana			
21	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	Moderate	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster
Kontruksi dan Renovasi			
22	Tembok retak	Tinggi	Pembangunan yang sesuai
23	Plafon retak	Tinggi	Pembangunan yang sesuai
24	Ruangan sempit	Ringan	Pembangunan yang sesuai
25	Ventilasi kurang	Moderate	Pembangunan yang sesuai
Pelatihan			
26	Tidak mengikuti pelatihan bencana	Moderate	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
27	Tidak ada pelatihan tata boga	Moderate	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku
28	STR dan SIP mati	Moderate	Perpanjangan STR dan SIP
Lingkungan			
29	Adanya semut	Tinggi	Area bersih dan pemberian perangkap
30	Adanya tikus	Tinggi	Area bersih dan pemberian perangkap

Tabel 5.2. Laporan Insiden Keselamatan / Manajemen Risiko

No.	Jenis IKP	Ringkasan Kronologi & Tindak Lanjut
1.	-	-

- Analisis :
1. Tidak terdapat insiden keselamatan/ manajemen risiko pada bulan Maret
- RTL :
1. Memberi edukasi kepada tim pengolahan dan penyaji untuk langsung membersihkan lantai saat ada cipratan minyak dan genangan air di lantai agar tidak terjadi kecelakaan kerja karena terpeleset
 2. Memberi edukasi agar lebih berhati-hati saat bekerja dan menggunakan APD sesuai standar yang telah ditentukan

VII. PPI

Tabel 6.1. Data Hasil Monitoring Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di Unit Gizi Januari 2026, Februari 2026, Maret 2026

No.	Komponen PPI	Jan		Feb		Mar	
		Y	T	Y	T	Y	T
1.	Penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien	V		V		V	
2.	Proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis	V		V		V	
3.	Makanan yang disiapkan dan disimpan dengan mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan		V	V		V	
4.	Distribusi makanan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan	V		V		V	
5.	Jika ada keluarga pasien yang membawakan makanan, beri edukasi kepada keluarga tentang pembatasan diet pasien dan resiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi	V		V		V	
6.	Pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien beresiko gizi	V		V		V	
7.	Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi	V		V		V	
8.	Evaluasi dan monitoring terapi gizi dan dicatat di rekam medis pasien	V		V		V	
9.	Penulisan PPA dan staf klinis melakukan pengisian e-RM dengan lengkap dan jelas	V			V	V	
10.	Pelaksanaan penyimpanan, pengolahan, pemorsian, termasuk packing, distribusi, pencucian alat makan dan alat masak serta kebersihan dan sanitasi dapur	V		V		V	
11.	Pelaksanaan penyimpanan bahan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi resiko infeksi		V		V	V	
12.	Pengisian suhu ruangan, suhu lemari pendingin, suhu freezer, dan pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur	V		V		V	
13.	Kesesuaian <i>hand hygiene</i> setiap selesai melakukan kegiatan yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan <i>hand wash</i> dan <i>hand rubs</i>		V	V		V	
14.	Kelengkapan fasilitas <i>hand hygiene</i> antara lain sabun, desinfektan, serta tissue / handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan desinfeksi tangan	V			V		V
15.	Pelaksanaan pelatihan tentang <i>hand hygiene</i> untuk semua petugas gizi	V		V		V	
16.	Kepatuhan penggunaan APD	V		V		V	
17.	Ketersediaan alat pelindung diri / APD	V		V		V	
Prosentase		82,3%		82,3%		94,1%	

Tabel 6.2. Kepatuhan PPI di Unit Gizi Tahun 2026

No.	Bulan	Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan		Audit Kepatuhan Pemakaian APD Unit
		Capaian OPP	Prosentase	Prosentase
1.	Februari	207	79,23%	95,9%

Sumber : Link PPI audit HH dan surveilens mutu SIMRS

Analisis :

- 1) Petugas penjamah makanan sudah mulai menerapkan 5 momen cuci tangan, harus saling mengingatkan agar terbiasa menerapkan 5 momen cuci tangan. Agar pencapaian HH meningkat.
- 2) Beberapa petugas penyaji masih belum hafal 6 langkah cuci tangan yang benar
- 3) Kepatuhan penggunaan APD bulan Maret 2026 perlu tetap dijaga dan saling mengingatkan bagi petugas penjamah makanan dan Ahli gizi. APD yang paling sering tidak digunakan adalah masker dan seragam.
- 4) Setiap seminggu sekali diadakan refresh terkait PPI.

RTL :

- 1) Kepatuhan penggunaan APD harus lebih diisiplinkan untuk menjaga makanan tetap higienis terutama petugas pengolahan.
- 2) Kepatuhan petugas dapur dan juga penjamah makanan harus lebih ditingkatkan lagi agar dikemudian hari tidak ada kontaminasi silang ke pasien karena ketidak patuhan petugas dengan cara sosialisasi pentingnya HH dan 5 momen.
- 3) Membersihkan lingkungan dapur setiap selesai kegiatan, meletakkan bahan makanan yang baru datang di tempat yang sudah ditentukan (bahan basah dimasukkan ke gudang beku, bahan kering dimasukkan kedalam gudang kering) dengan system FIFO dan FEFO.

VIII. PKRS

Tabel 7.1 PKRS Gizi

No .	EDUKASI	Target	Hasil	Media- Metode	TGL pelaksanaan	Tempat /KET
1.	Individu pasien Irna	100%	Pasien memahami edukasi yang disampaikan	Ceramah	Setiap Hari	Ruang IRNA
2.	Kelompok (penunggu, Pasien Irna, Pasien Poli, Komunitas	4x/bln	Peserta penyuluhan memahami materi yang diberikan	Ceramah	28, 29, 30, 31 Maret 2026	Ruang Tunggu Poli

Analisis :

- 1) Edukasi di rawat inap diberikan kepada setiap pasien baru masuk. Selain itu edukasi diberikan kepada pasien dengan perubahan diet atau perubahan tekstur makanan pasien.
- 2) Edukasi kelompok diberikan kepada pasien rawat jalan dan keluarga pasien di ruang tunggu poli.
- 3) Edukasi kelompok dilaksanakan setiap minggu sekali.
- 4) Materi yang diberikan adalah materi tentang diet pasien yang diberikan secara bergantian seperti diet DM, Rendah Protein, Rendah Lemak, Rendah Garam

RTL :

- 1) Bekerjasama dengan tim PKRS agar tidak hanya memberikan edukasi di ruang tunggu pasien tetapi juga dapat dilakukan di acara komunitas rumah sakit.

IX. MONITORING DAN EVALUASI

Tabel 8.1. Rekapitulasi Hasil Supervisi

No	STANDAR AKRE	Komponen	Dilakukan		Temuan Masalah	RTL	Prosentase	Total Prosentase
			Ya	Tidak				
1	TKRS 9	Terdapat Pedoman Pengorganisasian unit	√		-	-	100%	100%
		Terdapat Pedoman Pelayanan Unit	√		-	-	100%	
		Terdapat SPO Unit	√		-	-	100%	
2	KPS 4	Terdapat SPK Bagi Ahli Gizi	√		-	-	100%	100%
		Terdapat RKK Bagi Ahli Gizi	√		-	-	100%	
3	KPS 5	Terdapat Evaluasi Kinerja Staf	√		-	-	100%	100%
4	KPS 6	Setiap Anggota Instalasi gizi memiliki file kepegawaian	√		-	-	100%	100%
		Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi staf (Ijazah Pendidikan terakhir)	√		-	-	100%	
		Uraian tugas staf	√		-	-	100%	
		Penilaian kinerja staf	√		-	-	100%	
		Salinan sertifikat pelatihan di dalam maupun di luar rumah sakit yang telah diikuti.	√		Terdapat 1 ahli gizi yang belum mengikuti seminar atau pelatihan HACCP	Edukasi agar segera mengikuti seminar atau pelatihan HACCP	100%	

		Informasi kesehatan yang dipersyaratkan, seperti vaksinasi/ imunisasi, hasil medical check up.	√		-	-	100%	
5	KPS 17	Melakukan Kredensial bagi Tenaga Kesehatan Lain	√		-	-	100%	100%
		Bukti kredensial dicantumkan di file kepegawaian	√		-	-	100%	
6	MFK 6	Pencegahan kebakaran,melalui cek pemasangan regulator elpiji, ketersediaan isi gas elpiji	√		-	-	100%	100%
		penyediaan titik evakuasi yang aman serta tidak terhalang apabila terjadi kebakaran	√		-	-	100%	
		Penyediaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi alarm kebakaran	√		-	-	100%	
		Penyediaan fasilitas pemadaman api secara aktif meliputi APAR, hidran, sistem sprinkler	√		-	-	100%	
		Melakukan pembersihan cerobong asap dan blower secara berkala	√		Pembersihan fasilitas dapur dilakukan setiap hari oleh CS pantry	-	100%	
		Pencegahan kebakaran,melalui cek pemasangan regulator elpiji, ketersediaan isi gas elpiji	√		Cek pemasangan regulator dilakukan setiap hari untuk mencegah	-	100%	

					kebocoran gas penyebab kebakaran			
7	PMKP 4.1	Pasien yang mendapat diet sesuai	√		-	-	98%	95,2%
		Kejadian adanya benda asing dalam makanan	√		-	-	100%	
		Kejadian pasien tidak mendapat makan	√		-	-	100%	
		Kelengkapan pengkajian gizi	√		-	-	100%	
		Kepatuhan kebersihan tangan		√	Petugas dapur dan penjamah makanan masih ada yang jarang melakukan cuci tangan sesuai dengan 5 moment dapur	Edukasi dan pemberian teguran kepada petugas yang tidak disiplin melakukan 5 moment	81,25%	
		Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	√		-	-	87,8%	
		Kepatuhan Identifikasi pasien	√		-	-	100%	
8	PMKP 9	Adanya kejadian yang tidak diharapkan (KTD)	√		-	-	100%	100%
		Adanya kejadian yang tidak cedera (KTC)	√		-	-	100%	
		Adanya kejadian nyaris cedera (KNC)	√		-	-	100%	
		Adanya kejadian potensi cedera (KPC)	√		-	-	100%	
		Adanya kejadian sentinel	√		-	-	100%	

9	PPI 8	Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) pemilihan Bahan makanan	√		-	-	100%	97%
		Bahan pangan yang tidak dikemas berlabel berasal dari sumber yang jelas dipercaya, baik mutunya, utuh dan tidak rusak	√		-	-	100%	
		Bahan pangan kemasan harus mempunyai label, terdaftar atau ada ijin edar dan tidak kedaluwarsa, Pangan kemasan kaleng tidak menggelembung, bocor, penyok, dan berkarat.	√		-	-	100%	
		Jika bahan pangan tidak langsung digunakan maka bahan pangan harus diberikan label tanggal penerimaan dan disimpan sesuai dengan jenis pangan		√	Masih ada bahan makanan yang tidak diberi label saat setelah dibersihkan	Mengarahkan petugas dapur untuk segera memberikan label tanggal pembelian pada saat ditemukan tidak ada label tanggal pembelian	88%	
		Bahan mentah dari hewan harus disimpan pada suhu kurang dari atau sama dengan 4 o C. Jika tidak memiliki lemari pendingin dapat menggunakan coolbox dan coolpack atau dry ice atau es balok yang	√		-	-	100%	

		dilengkapl dengan termometer untuk memantau suhu kurang dan atau sama dengan 4 oC						
		Bahan pangan beku yang tidak langsung digunakan harus disimpan pada suhu – 10°C atau di bawahnya	√		-	-	100%	
		Penyimpanan harus menerapkan prinsip First In First Out (FIFO)	√		-	-	100%	
		Setiap bahan pangan ditempatkan secara terpisah dan dikelompokkan menurut jenisnya dalam wadah yang bersih, dan tara pangan (food grade)	√		-	-	100%	
		Ada catatan keluar masuknya bahan makanan	√		-	-	100%	
		Suhu gudang bahan pangan kering dan kaleng dijaga kurang dari 25 oC		√	Suhu gudang kering naik turun antara 25-26°C	Memberikan kipas angin didalam gudang kering dan wajib menup pintu saat keluar masuk untuk menjaga suhu gudang kering	88%	
		Semua bahan pangan hendaknya disimpan pada rak-rak (pallet) dengan ketinggian atau jarak rak terbawah kurang lebih 15 cm dari lantai, 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit-langit.	√		-	-	100%	

	Rutin mengisi monitoring suhu setiap ruangan di instalasi gizi	√		-	-	100%	
	Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) pengolahan bahan makanan	√		-	-	100%	
	Bahan pangan yang akan digunakan dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir sebelum dimasak	√		-	-	100%	
	Pengolahan bahan makanan memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi	√		-	-	100%	
	Bahan pangan beku sebelum digunakan harus dilunakkan (thawing] sampai bagian tengahnya lunak,	√		-	-	100%	
	Pangan dimasak sampai matang sempurna	√		-	-	100%	
	Tempat/wadah penyimpanan terpisah dari setiap jenis makanan dan mempunyai tutup	√		-	-	100%	
	Makanan matang tidak dicampur dengan makanan mentah	√		-	-	100%	
	Adanya sample makanan yang disimpan 1 kali 24 jam	√		-	-	100%	
	Penyajian pangan matang harus bersih dan terhindar dari pencemaran.	√		-	-	100%	

		Pangan matang yang mudah rusak dan disimpan pada suhu ruang harus sudah dikonsumsi 4 jam setelah matang, jika masih akan dikonsumsi harus dilakukan pemanasan ulang	√		-	-	100%	
		Wadah/peralatan yang digunakan harus higienis, utuh, tidak cacat atau rusak	√		-	-	100%	
		Makanan disajikan tepat menu, tepat waktu, tepat tata hidang dan tepat volume (jumlah)	√		-	-	100%	
		Ada identitas pasien pada setiap box makanan pasien	√		-	-	100%	
10	PPI 11	Cek kesesuaian hand hygiene setiap selesai melakukan kegiatan yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan hand wash dan hand rubs	√		Petugas penjamah makanan masih belum disiplin dalam melakukan hand hygiene	Memberikan teguran dan Sosialisasi tentang hand hygiene kepada penjamah makanan.	79,23%	93,07%
		Cek kelengkapan fasilitas hand hygiene antara lain sabun, desinfektan, serta tissu/ handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan desinfeksi tangan	√		-	-	100%	
		Cek pelaksanaan pelatihan tentang hand hygiene untuk semua petugas gizi	√		-	-	100%	

11	PPI 11.1	Cek pelaksanaan pelatihan tentang penggunaan APD untuk semua petugas gizi	√		-	-	100%	100%
		Cek kepatuhan penggunaan APD	√		-	-	100%	
		Cek ketersediaan alat pelindung diri/ APD	√		-	-	100%	
12	PP 1.2	Adanya regulasi tentang kriteria risiko nutritional	√		-	-	100%	100%
		Adanya bukti Rekam Medis pengkajian awal skrining risiko nutrisi.	√		-	-	100%	
		Bukti Rekam Medis pengkajian gizi untuk pasien dengan risiko nutrisional.	√		-	-	100%	

Analisis :

1. Dari hasil supervise terkait regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi tidak ditemukan temuan khusus yang bertentangan dengan regulasi pelayanan gizi dengan prosentase 100%. Terdapat 1 ahli gizi yang belum mengikuti pelatihan/ seminar HACCP
2. Dari hasil supervise terkait regulasi yang berkaitan dengan terapi gizi terintegrasi tidak ditemukan temuan khusus yang bertentangan dengan regulasi terapi gizi terintegrasi dengan prosentase 100%.
3. Dari hasil supervisi tentang sarana prasarana instalasi gizi dilakukan pemeliharaan berupa pembersihan setiap hari, pengecekan dari vendor terkait vektor dilakukan seminggu sekali
4. Dari hasil supervisi terkait PMKP unit ada pelanggaran terkait pemberian diet kepada pasien sebanyak 2 kejadian
5. Dari hasil supervisi terkait PPI patuh dalam penggunaan APD, namun belum patuh cuci tangan, pemberian label pada makanan matang tidak langsung digunakan, dan tidak disiplin dalam menutup pintu gudang kering saat keluar masuk gudang sehingga mengakibatkan suhu gudang kering tinggi.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

1. Pertahankan pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan gizi rumah sakit.
2. Kepatuhan dalam mengerjakan asuhan gizi di rekam medis harus dipertahankan dengan cara lebih teliti lagi, dan jika mengerjakan tidak boleh terburu-buru.
3. Mengupdate ilmu gizi dengan mengikuti pelatihan eksternal maupun internal yang diadakan oleh rumah sakit.
4. Identifikasi pasien saat memberikan edukasi, mendistribusikan makanan kepada pasien wajib dilakukan oleh seluruh petugas.
5. Kepatuhan penggunaan APD lebih ditingkatkan lagi dengan cara mengshare nama - nama petugas yang tidak patuh setiap bulannya dan data dikirimkan ke SDM.
6. Kepatuhan petugas dapur dan juga penjamah makanan harus lebih ditingkatkan lagi agar dikemudian hari tidak ada kontaminasi silang ke pasien karena ketidak patuhan petugas dengan cara sosialisasi pentingnya HH dan 5 momen, membersihkan lingkungan dapur setiap selesai kegiatan, meletakkan bahan makanan yang baru datang di tempat yang sudah ditentukan (bahan basah dimasukkan ke gudang beku, bahan kering dimasukkan kedalam gudang kering) dengan system FIFO dan FEFO.
7. Kepatuhan dalam pengisian form keluar masuk alat makan harus dihitung dengan benar dan tidak boleh dirapel, mengshare nama petugas yang tidak patuh dalam pengisian.
8. Kepatuhan dalam mengembalikan tirai PVC setelah membersihkan area gizi agar tirai tidak rusak karena di singkap dan diletakkan dengan posisi tidak pada tempatnya.
9. Kepatuhan dalam pengisian suhu ruangan tidak boleh dirapel, agar hasil yang didapat valid dan jika ada masalah bisa segera di TL. Mengshare nama petugas yang tidak patuh dalam pengisian.
10. Review sosialisasi terkait pentingnya APD, HH dan pengisian suhu harus diberikan setiap satu bulan sekali saat rapat bulanan unit.
11. Pintu penerimaan bahan makanan dan pintu ruang ganti karyawan wajib ditutup setelah keluar masuk, agar vector yang dari luar tidak masuk ke area instalasi gizi.

Tabel 8.2. Komplain Gizi

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan November 2025	Jumlah Komplain Bulan Desember 2025	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	0	0	1
	ISI KOMPLAINAN	- <i>Komplain dari karyawan (no name) bubur kacang hijau snack pasien yang sisa diberikan kepada karyawan. Dan karyawan yang menemukan komplain terkait ada kutu di bubur kacang hijau.</i>		
	Analisis	- Ditemukan banyak kutu di kacang hijau, diduga saat penerimaan kacang hijau dalam keadaan baik, namun kutu menetas - Pencucian dan perendaman kurang maksimal		
	RTL	- Memperhatikan kebersihan wadah kacang hijau - Menerapkan prinsip FIFO FEFO ditingkatkan lagi		

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Desember 2025	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026
2.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	0	1	1
	ISI KOMPLAINAN	- <i>Pasien V2 lantai 2c bernama Zhafran Alkhairy (5 Februari 2026) mendapatkan menu perkedel pada hari tersebut. Keluarga pasien komplain terkait perkedel yang asam. Dan menu penunggu untuk pasien VIP mengapa sama dengan makan pasien.</i>		
	Analisis	- Pemilihan kentang yang baik berpengaruh pada hasil matang, karena banyak ditemukan kentang yang datang bertekstur lunak saat setelah dikupas. - Mengkaji dan memberi usulan menu kepada pemegang kebijakan.		
	RTL	- Memilih dan menerima bahan makanan basah sesuai spesifikasi - Mengajukan usulan menu baru kepada pemegang kebijakan disertakan dengan bukti.		

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026	Jumlah Komplain Bulan Maret 2026
3.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1	1	2
	ISI KOMPLAINAN	- Pasien 4A atas nama Bu Krisna komplain makan pagi tidak ada nasi. - Pasien 4A atas nama Pak Jahman komplain makanan bekas pasien lain diberikan kepada pasien.		
	Analisis	- Tidak dilakukan check ulang sesudah pemberian nasi. - Penyaji Tiyas kehabisan makanan untuk pasien baru, sehingga meminta kepada penyaji Dwi Ratna untuk meminta cadangan makan lantai yang dibagi. Dwi Ratna memberikan cadangan makan tanpa dicek dahulu. Dan penyaji Tiyas menerima tanpa mengecek dahulu juga, sehingga box makan diterima pasien dalam keadaan sudah dimakan.		
	RTL	- QC makanan sebelum ditutup, harus dilakukan double QC. - Perlu adanya check ulang sebelum pendelegasian kepada teman, dan teman yang menerima harus melakukan check ulang kembali.		

X. JADWAL (SCHEDULE)

[illegible]

[illegible]

XI. PENUTUP

Dari hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan petugas gizi dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit. Namun untuk petugas penjamah makanan perlu dilakukan supervise lebih lanjut secara berkala agar kepatuhan dalam menggunakan APD dan kebersihan tangan dapat ditingkatkan.

Adanya monitoring secara berkala dari kepala unit maupun jajaran manajemen di atasnya dapat meningkatkan kepatuhan dari petugas unit gizi.

Mengetahui
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

Malang, 05 April 2026
Kepala Unit Gizi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chandrawati Mustikasari'.

Plt. Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz

A. LAMPIRAN KUANTITAS SDM

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan Dasar RS						Ket.
		Standar	Kondisi saat ini	Mutu dan Keselamatan Pasien	BLS	PPI	Penanggulangan Bencana	Komunikasi Efektif	NCP (<i>Nutrition Care Process</i>)	
Ka. Penunjang Medik	-	Dokter	Bidan	-	-	-	-	-	-	-
Ka. Unit	Ericha Risdawati, AMd.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	-
Pelaksana Gizi	Suci Nur Pratiwi, S.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	Beberapa tidak ada sertifikat.
Pelaksana Gizi	Veni Lestari Puri Purnami, AMd.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	Beberapa tidak ada sertifikat.
Pelaksana Gizi	Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Gizi	Chandrawati M., S.Tr.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Gizi	Nafisah Ulfa H., S.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Suryani	D1/SMA/K	SMP	√	√	√	√	√	-	

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan Dasar RS						Ket.
		Standar	Kondisi saat ini	Mutu dan Keselamatan Pasien	BLS	PPI	Penanggulangan Bencana	Komunikasi Efektif	NCP (<i>Nutrition Care Process</i>)	
Pelaksana Dapur	Deri Untari	D1/SMA/K	SMP	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Siti Sulistyowati	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Suriyanti	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Della Karisma Zakenda	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Riski Dwi Andriani	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Dewinta Laili Rahmadia	SMA/K	SMA	√	-	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Sabrina Nasywa M	SMA/K	SMK	√	-	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Duwi Ratna Yulianti	SMA/K	SMK	√	-	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Tiyas Ninda Ekasari	SMA/K	SMK	√	-	√	√	√	-	

No.	Nama	PK	Jabatan	Skill	Knowledge	Attitude							Catatan
						J	T	V	D	K	A	P	
3.	Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	C	B	B	B	B	B	Harus melakukan doble QC setelah pemberian nasi, agar tidak terlewat
4.	Chandrawati M., S.Tr.Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5.	Nafisah Ulfa H, S.Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6.	Suryani	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	C	C	C	B	C	Kurang dalam tanggungjawab terutama pada saat penerimaan sayur
7.	Deri Untari	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	C	B	
8.	Siti Sulistyowati	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9.	Suriyanti	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	B	C	B	
10.	Della Karisma Zakenda	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
11.	Riski Dwi Andriani	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Lebih bertanggung jawab lagi jika diberi amanah
12.	Dewinta Laili Rahmadia	-	Pelaksana Dapur	C	B	B	B	C	B	B	B	B	
13.	Sabrina Nasywa Mufida	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	C	C	C	Lebih peduli pada lingkungan sekitar

No.	Nama	PK	Jabatan	Skill	Knowledge	Attitude							Catatan
						J	T	V	D	K	A	P	
14.	Duwi Ratna Yulianti	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	C	B	B	Memberi makanan tanpa mengecek dahulu, makanan sudah dimakan pasien diberikan
15.	Tiyas Ninda Ekasari	-	Pelaksana Dapur	B	C	B	C	B	B	C	B	B	Memberi makanan tanpa mengecek dahulu, makanan sudah dimakan pasien diberikan

Keterangan: B = Baik
C = Cukup
K = Kurang

B. LAMPIRAN MUTU UNIT

[illegible]

C. LAMPIRAN KEUANGAN UNIT GIZI (DAPUR)

[illegible]

[illegible]

No	Keterangan	Nominal						Total
		29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025				
	Pengeluaran :							
1	Bahan Makan Pasien	1440000	1320000	2172000				4932000
2	Bahan Makan Karyawan	480000	440000	724000				1644000
3	Bahan Makan Rumah Tangga	120000	110000	181000				411000
4	Bahan Makan Tamu	360000	330000	543000				1233000
		2400000	2200000	3620000				8220000
								8220000
								81800339

LAMPIRAN PENGELUARAN UNIT DAPUR 2026

NO	BULAN	TOTAL PENGELUARAN
1	Januari	Rp. 83.667.200
2	Februari	Rp. 76.391.500
3	Maret	Rp. 81.800.339
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-

7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-

D. LAMPIRAN FOOD WASTE (SISA MAKANAN)

Siklus menu pada bulan Maret

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	
1.	Karbohidrat	Nasi	65,9	54,4	57,8	75% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan Maret 2026 meningkat 0,7% dari bulan Februari 2026
		Nasi Tim	101,3	83,6	82,2	
	Total		167,2	138	140	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang pada bulam Maret tidak ada sisa yang kembali dari pasien.
		Setup Pisang	0	0	0	
		Kacang Hijau	0	0	0	
		Kue Hongkong	0	0	0	
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	0	0	0	
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0	0	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0	0	
		Brule Bomb	0	0	0	
	Total		0	0	0	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret.
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	3,3	3,6	2,7	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	4,4	4	2,6	
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)				
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	3,5	3,6	2,4	
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)				
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon	11,2	11,2	7,7	
	Total					
2.	Menu 2					
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4,2	4	2,2	

		Tahu Rempah (Remet)				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Rebus				
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	3,8	3,9	3,8	
		Ayam Wijen				
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Telur Gulung	3,5	3,4	2,3	
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)				
		Telur dadar tebal				
	Tambahan VIP	Tempe goreng				
	Total		10,5	11,3	8,3	
3.	Menu 3					
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,9	3,9	2,7	
		Tahu Krispy				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	3,4	3,9	2,7	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)				
		Rolade Ayam				
		Tahu Goreng				
	Tambahan VIP	Tempe Bacem	3,2	3,9	3,2	
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)				
		Telur rebus				
	Tambahan VIP	Tempe goreng				
	Total		10,5	11,7	8,6	
4.	Menu 4					
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,6	3,7	3,6	
		Tahu Nugget				
		Abon				
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar				

	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	1,5	2,7	3,9
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			
	Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sas u polong orang	3,4	2,8	3,5
		Jamur goreng			
	Tambahan VIP	abon			
Total			8,5	9,2	11
5.	Menu 5				
	Bulan		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	2,8	3	3
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,9	2,9	3,6
		Ayam Bombay			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Tahu Krispy			
	Sore	Soto ayam	4,2	4	3,5
		Telur rebus			
		VIP= Perkedel ayam			
	Total		10,9	9,9	10,1
	Total Sisa Menu tanpa KH		51,6	53,3	45,7
	Total Keseluruhan dengan KH		218,8	191,3	185,7

3.2.5.10 Tabel Rekap Food Waste pada Tahun 2026

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2026	218,8
2.	Februari 2026	191,3
3.	Maret 2026	185,7
4.	April 2026	-
5.	Mei 2026	-
6.	Juni 2026	-
7.	Juli 2026	-
8.	Agustus 2026	-
9.	September 2026	-
10.	Oktober 2026	-
11.	November 2026	-

E. LAMPIRAN PEMANTAUAN AIR PANAS DI PENCUCIAN ALAT MAKAN

	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15								
	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr						
Batas suhu min (°C)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75				
Batas suhu maks (°C)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80				
Nilai Suhu (°C)	75	75	85	75	85	80	75	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57						
Inisial Staff	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an
Supervisi Karu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			

TANGGAL																																																
16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			
P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr	P	S	Sr				
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75			
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			
58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	58	57	58	59	57	57	
an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	sm	sm	sm
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		

F. LAMPIRAN KEHILANGAN/KERUSAKAN ALAT MAKAN

DATA NAMA PASIEN MENGHILANGKAN / MERUSAKKAN ALAT							
NO.	TANGGAL	RUANGAN	NAMA PASIEN	KWITANSI	DOKUMENTASI	Nama Alat	KET
DESEMBER 2025							
1	01/12/2025	C3C-3	SYABIL ISMAIL DWIFARO	-	-	GELAS	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar pergantian ke kasir
JANUARI 2026							
1	06/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas tiba-tiba retak, tidak layak pakai
2	12/01/2026	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.

3	13/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas mengalami pemuaian saat diangkat oleh CS dan pecah di trolly.
4	17/01/2026					SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok makan sudah tidak layak pakai karena berkarat.
5	20/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	

6	20/01/2026	D7A-5	Bakri	-		BOX MAKAN PECAH	Pasien memecahkan box makan merah, namun pasien tidak bersedia membayar dan pulang.
7	21/01/2026	C4B-3	Amelia Novita Sari	-		SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok hilang terbawa pasien pulang
8	27/01/2025	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.

9	30/01/2026	D6A-2	Sukirno	-		SENDOK MAKAN PASIE	Sendok hilang terbawa pasien pulang
FEBRUARI 2026							
1.	06/02/2026	-	-	-		GELAS PASIE	Saat menuangkan teh, gelas retak. Sudah tidak layak pakai
2.	07/02/2026	C4A-2	HADI SUTRISNO			GELAS PASIE	Pasien memecahkan gelas dan sudah dibayar
3.	15/2/2026	-	-	-		MANGKOK KECIL SNACK	Pecah oleh penyaji Tiyas
MARET 2026							

1.	08/03/2026	-	-	-		Box merah	Box merah pecah
2.	11/03/2026	D6A-12	MIFTAKHUL JANA			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir
3.	22/03/2026	ICU	SARMI KUSUMAWATI			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir

RINGKASAN LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN REKTAL SWAB PETUGAS PENJAMAH MAKANAN

Pada tanggal 22,23,30 Januari 2026, telah dilakukan pemeriksaan rectal swab pada petugas penjamah makanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang oleh Laboratorium Klinik Panglima Sudirman dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PETUGAS	HASIL	KESIMPULAN	KETERANGAN
1	Siti Sulistyowati	Normal	• Layak Bekerja Penjamah Makanan	• Biakan <i>Staphylococcus</i> koagulase negatif
2	Sabrina Nasywa	Normal	• Layak Bekerja Penjamah Makanan	• Biakan <i>Escherichia coli</i>
3	Suriyanti	Normal	• Layak Bekerja Penjamah Makanan	• Biakan normal <i>Escherichia coli</i>
4	Riski Dwi	Tidak normal	• Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	• Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
5	Della Karisma	Tidak normal	• layak bekerja dengan higiene sanitasi yang ketat.	• Biakan normal <i>Staphylococcus</i> koagulase positif
6	Dewinta Laili R.	Normal	• Layak Bekerja Penjamah Makanan	• Biakan normal <i>Escherichia coli</i>
7	Deri Untari	Tidak normal	• Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	• Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
8	Surya	Tidak normal	• Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	• Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
9	Tiyas Ninda Eka	Tidak normal	• Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	• Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
10	Duwi Ratna Y	Tidak normal	• Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	• Biakan normal <i>Salmonella sp</i>

Demikian hasil ringkasan pemeriksaan rectal swab petugas penjamah makanan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai pada lampiran hasil dan agar dapat dilakukan tindak lanjut guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit.

